

感冒29天后逝去，是什么打垮了“流感下的北京中年”？

原创 中医二羊 养阳医斋 2018年2月13日 11:17

这两天被《流感下的北京中年》刷屏了，第一次看让人觉得难过和同情作者，看第二遍的时候我有一些愤怒、无奈和悲凉。

愤怒的是一场感冒在现代那么科学发达的今天既然也能就要了人命！

无奈的是作为一名医务工作者面对疾病的凶猛很多时候也常常感到无力！

悲凉的是一个感冒患者从门诊到ICU到最后离去，这过程中折射出来的过度医疗问题！

作者是一个很用心的家属，把治病的整个过程都记录下来了，两万六千字是对岳父感冒离去的悼念也是一个普通病患家属心理直接描绘。

我最大的困惑在于现代医学给出的诊断以及治疗方法大相径庭，好无奈、好悲凉！

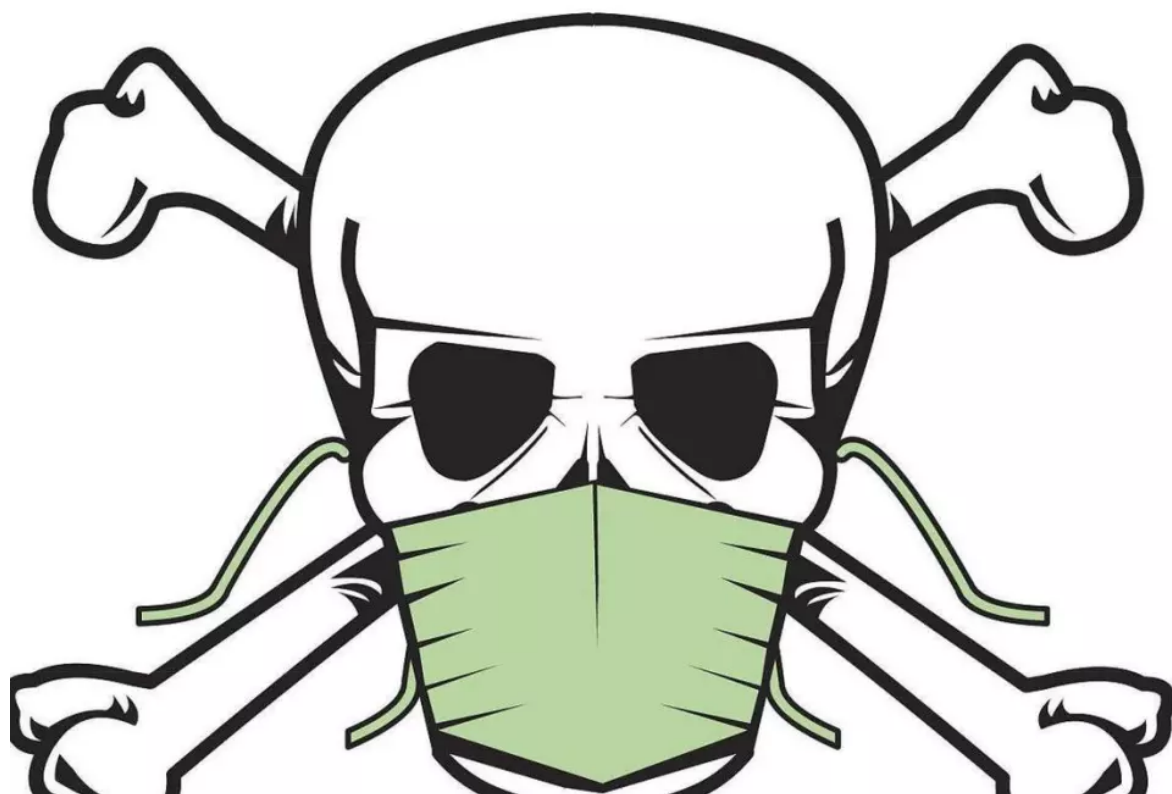
岳父感冒，被解释为一种不知名的病毒。好吧，限于现在医学的水平，查不出什么病毒就算了，这么发达的医学又既然在用“抗生素”、头孢这些抗菌素治疗！

西医明明知道病毒感染是自限性的，也就是说没有特效药，只能改善病毒引起的不适症状和并发症。并不能真正的杀病毒，关键是既然是病毒感冒你用抗菌素？抗菌素不是治疗细菌感染的吗？抗菌素不是副作用很大的吗？

这太正常了，一感冒发烧就用抗生素，这是最最普遍的临床用法！发烧了除了“三素”两汤”（抗生素、维生素、激素）加葡萄糖、生理盐水。还有其他更好的办法吗？

当然有，解热镇痛药等等，殊不知这些都只是改善症状的。但目前主流的医疗，被药商推动下，过度医疗在这个事例中体现的真真切切！关键是最后病患死了，医生不知道原因，家属也不知道，只能归罪于不知名的病毒还有上了年纪！

我想说，这里边过度医疗、错误的治疗是加速这位感冒老爷子离去的主要原因！



为了更好的明白老爷子为什么离去，我把这当做一个临床案例复盘研究了一番，看看能否看到病情变化的关键。

流感下的北京中年

女儿：“姥爷怎么这么长时间还不回来？”

妈妈：“姥爷生病了，在医院打针。”

作者用日记录岳父从流感到肺炎、从门诊到ICU，29天阴阳两隔的经历。涉及就诊、用药、开销、求血、插管、人工肺（ECMO）等医疗现实。

流感

女儿：“姥爷不听话，光膀子，感冒啦！”

12月27日（星期三）

下午，阳光灿烂，岳母打开主卧窗子通风。岳父忽然来了个念头...，并且坚持不穿上衣，吹了半小时。

得病：岳父是开窗通风，不传上衣得的病。这个是感冒最常见的诱因吗？西医很少关注这些、自然界的风、寒、湿等等，但中医却把这些看的很重，且黄帝内经强调，“虚邪贼风避之有时，病安从来”。很多人一吹风、着凉了就会感冒，这几乎人人都有有关的体验。不可忽视了！

12月28日（星期四）

岳父开始感冒流涕。

病历：患者是男性，60岁，因为咳嗽、咳痰12天，发热11天，于2018年1月8日入院。

表现为：“**岳父东北man式喷嚏，瀑布式流鼻涕，还拿孩子尿不湿来吸鼻涕。**”很典型的感冒症状，在中医看来风寒表证，鼻涕很多可能里边水饮比较多。我遇到可能会考虑用桂枝汤、小青龙汤来治疗，因为之前遇到这样的感冒吃两三剂就好了。

12月29日（星期五）

岳父开始发烧，愿意吃感冒药了。

第一天只是喷嚏、流清鼻涕，第二天开始发烧。开始吃感冒药。不知道吃的啥感冒药，不知道这发烧的同时有没怕冷的情况？如果有怕冷、恶寒、那在二羊看来这还是风寒感冒。通过发汗解表的方法就能解除。

12月30日（星期六）

岳父挺不住了，去了通州民营医院甲。验血后开了3天输液，消炎药用的是头孢。输液后，岳父有改善

感冒一上来就用消炎药，这里有验血，不知道是否血象提示有细菌感染？白细胞高、中性粒细胞高？用了头孢抗生素，自己觉得症状缓解。

这个缓解是喷嚏、流鼻涕发烧有改善？身体好了？还是病邪被压进去了？中医来说“脉若静者为不穿，脉数急者为传也”。是表证解除了还是病往里走了，只能继续看下文。

不过作者的原话反应出活生生的医疗现实“美国感冒，看个大夫150美金，看完让你回去喝水。中国感冒，看个大夫5元人民币，输液1000人民币。继房价之后，医疗价格也在赶超美国。”

同样是西医，同样是看感冒怎么差别就那么大呢？

这条小孩和岳母也发烧了，看来这个流感还挺厉害！

通过输液岳母好了，孩子的发烧也得到控制了，具体不详。

1月3日（星期三）

岳父承认病情恶化，照片提示肺炎。白血球低，阿奇霉素输液，发烧不盖被子

经过三天抗生素治疗后，岳父反而差了，提示肺炎，白血球底？肺炎一般情况下白血球都是升高的，他不高反而低？不是细菌感染？免疫力低下了？换了阿奇霉素静滴，抗生素又来了，倒是是不是细菌引起的肺炎都还不知道。发热不愿意盖被子，这是发热不恶寒反恶热，病往里走了。

如果说刚开始发热是在太阳，这时候到阳明，也就是病从表往里走了。

1月4日（星期四）

情况严重，检查 CT：肺部大面积感染（对比之前）。甲流、乙流都是阴性排除这个两类流感。

连续的抗生素治疗没有把病控制住，反而加重了，可能是这个病太重了，这两位常规的抗菌素都没用，但也有一种可能，治疗不仅不对反而引起了加重？

1月4日（星期四）21点，朝阳医院，第二天再转下一家医院，肺部病毒扩散很快，需要呼吸机。买达菲

换了一家医院推诿搞不定之后，在换了另一家医院，评估很严重，得上呼吸机了。并且让家属买达菲，这个时候想起来用抗病毒的药了。

12天前（2017-12-28）

患者劳累后出现咳嗽、咳黄白痰，量较多，易咳出，伴轻度头痛、流涕、浑身肌肉酸痛。无明显胸闷、胸痛、呼吸困难，无恶心呕吐、腹痛、腹泻。未治疗。

1月8日（星期一）上午 丁医院

期间略有好转，但很快，“一线抗生素都用了，但病毒没有控制住，B超提示：继续扩散，整个肺已经被病毒占据

不知道这是不是医生的原话，还是作者记错了。病毒跟细菌是差别很大的。如果是医生的原话就是这样，那这只是一个笑话了。**一线抗生素都用了，但病毒没有控制住？！那本西医教科书或者指南说的，用抗生素来控制病毒的？**那如果不是细菌感染，猛烈的抗生素打下去，只会人不行，病毒是不会死的！抗菌素是杀细菌的对病毒根本没用，这个是普通的医学生都知道的常识。

1月8日（星期一）下午 戊医院-10日

ICU不让家属进，每天只有下午半小时探视时间。期间岳父精神突。

不得不再次换了医家医院，住进ICU,刚开始几天病情似乎有好转，但是接下医生评估

并且，说得插管。不是好一点了吗？为什么突然又插管了？

这个评估并且，似乎医生都不看患者精神、饮食等等，凭一张检查报告说不行，这就开始插管了，接下来还用了人工肺。在中医看来病是好还是差了，除了摸脉判断另外一个就是看患者的吃喝拉撒，尤其是吃喝精神，如果有好转代表病往好的方向发展了，反之则变差。

1月12日（星期五） 上午11点

岳母在医院急电：“今早拍片结果还是不行，医生准备上人工肺。”

从小病房移到了大病房，全身上下都是管子。

尊的患者同意后，一个大活人，被强行镇静，开始了所谓的“治疗”，中间挣扎的机会都没有。当然西医专家们的建议治疗方案如此，患者和家属只能接受。

1月18日（星期四） 晚上

岳父情绪激动，努力眨眼睛想要和他们说话。监控当即显示心跳加快、呼吸频率飙升，医生赶忙加大的镇静剂量，并让亲属离开病房。

本来可以很快从icu出来，结果上了人工肺不但没好，好不容易挣扎的一次机会都被剥夺了，医学很好，但有时候一点人性都没有。人只不过是一个器官。一台仪器，你肺部好了，我们可以用人工的给你用，前提是要把你麻醉，让你的大脑和其他器官先别挣扎。

1月22日（星期一）

下午4点30分，夫人来电：“今天做了CT，结果出来了。”

大夫和家人沟通，话很委婉：

1) 会诊认为医学上没有继续治疗必要。肺部全部被细菌和病毒感染，呼吸衰竭，肾功能衰竭，肝功能衰竭，消化道出血，蛛网膜下腔出血，低蛋白，高钾血症，高钠血

症。

2) 建议病人转院。组后只能回家.....

一感冒开始就用那么多抗生素，不肝衰、肾衰才怪了。这不禁让我想起扁鹊见蔡桓公。

扁鹊告诫蔡桓公“**君有疾在腠理 不治将恐深**”

这个案例让我看到的却是相反的，君有疾在腠理，我们把他治进去。最后，君有疾在骨髓了，好了可以回家料理后事了。

这是一个让人沮丧的案例，让人悲伤，无奈。假如自己是作者，你怎么办？还不是一步步的这一走过来。当一个没有一点医疗常识的中年大叔突然面对这样一些，也只能跟着医生说的走。

按理说，如果是正确的治疗方法，只会越来越好。换了人工费之后，并且不但没好，反而越来越重了，最后整个人都不行了。进了ICU十之八九人才两空，让人一点尊严都没有。怪不得上学时一个老师说，你们努力学中医争取老了不要让自己住进ICU。

一些流感虽然来的迅猛，但很多时候医学不能救人，反而是医学害了人。

中医古人说的，有病不治常得“中医”，有些病不去看医生相当于得到了中等医生的医治。我们人的身体，没有那么顽强，但并没有想象中的那么脆弱。例如怕扁桃体发炎切了它，怕乳腺癌，把乳房切了等等。

做为一个临床工作者，我尊重我的西医同行，我尊重现代医学，但是这个患者的经历，一步步从感冒到最后离开，让我们看到了太多的过度医疗。

许多西方发达的“西医”可能都不会的治疗方法和手段，但是在这片神奇的土地上，西医可以发展成为区别于西方西医的另一大奇迹。

作为一个中医，面对这样的患者。从中医的角度上我发表了自己的一点看法，但作为一个潜在患者或者家属，又也让我哀伤和愤慨。

西医自然有它的优势，只是目前国内的西医过度医疗太多太多了。中医也有它的优势，目前国内好的中医能治病的中医也太少太少了。

有一位西医同僚质问我，中医能治糖尿病、高血压吗？西医就可以。

我说，很多人得病了，西医让他吃一辈子的药，直到死为止！能让人吃药吃一辈子还引以为豪，我都觉得这是医学的耻辱，有什么好自豪的！

同样，看完这个让人沮丧的案例，也是给我当头一棒。说不定，我自己也很大可能成为一个救不了患者反而害了患者的庸医。

作为一个医者，告诫自己，警醒自己。

医圣张仲景因为家族人得了流感死了上百人，才发心写《伤寒杂病论》。只是希望，不要每一个人都要经历了同样的伤痛才来反省。当然，每一个人都有他自己的信仰和选择，只是后果让自己来承担罢了。

逝者已逝，愿他安息。

生活继续，我们到底该怎样走接下来的路.....

中医是一种爱好，一种态度，也是一种生活。



如果对你有帮助，欢迎分享

iPhone 用户赞赏专用



中医二羊

广州中医药大学中医硕士，主导针药并治的大中医观，一个推崇经典古中医的80后中医。

一个铁杆中医脑残粉。有一味赤色栀子心，胸怀山中药，愿为熊胆使君子，继四圣岐黄之术。

